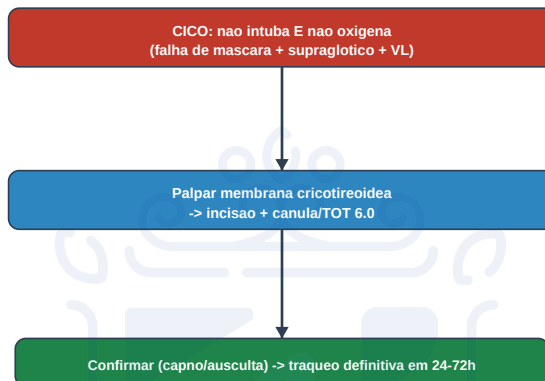


CRICOTIREOIDOSTOMIA — CICO + MEMBRANA

FLUXOGRAMA — CICO

CICO -> VIA AÉREA CIRÚRGICA PELA MEMBRANA



DEFINIÇÃO E OBJETIVO

ÚLTIMO RECURSO DE VIA AÉREA

- Incisão na membrana cricotireoideia para inserir uma cânula e ventilar quando a via aérea superior é inacessível
- Objetivo: estabelecer via aérea definitiva de emergência no cenário CICO ('Can't Intubate, Can't Oxygenate')
- É o ÚLTIMO RECURSO — após tentativas adequadas e rápidas de manejos não cirúrgicos (máscara, supraglótico, videolaringoscopia)
- Marco anatômico: membrana cricotireoideia, entre a cartilagem TIREOIDE e a CRICOIDE
- Não retardar quando indicado — a hipoxemia prolongada é fatal

INDICAÇÕES (CICO)

REALIZAR IMEDIATAMENTE QUANDO

- Cenário CICO: impossibilidade de intubar E de ventilar com máscara/supraglóticos
- Trauma facial grave ou edema importante de vias aéreas superiores
- Hemorragia maciça oral/nasal impedindo a visualização
- Obstrução anatômica intransponível (tumor, anafilaxia com edema importante)
- Falha repetida de dispositivos alternativos (videolaringoscopia, supraglótico)

CONTRAINDICAÇÕES

Tipo	Observação
Absoluta	NENHUMA no cenário de emergência CICO
Relativa — idade	Crianças pequenas (< 5-12 anos): risco de estenose subglótica — preferir broncoscopia rígida/traqueostomia por especialista, se disponível e seguro
Relativa — anatomia	Cirurgia cervical prévia, laringe/traqueia muito alterada

TÉCNICA ABERTA (PADRÃO-OURO)

Rx PASSO A PASSO

Preparo: decúbito dorsal com leve hiperextensão cervical (se sem lesão cervical); antisepsia; identificar pomo de Adão, cricoide e a membrana

Material: bisturi (lâmina 10/11), pinça/dissector, cânula de cricostomia ou TOT nº 6,0 (5,5-8,0), guia/dilatador (Seldinger), seringa, fixação, ambu

1) Palpar e marcar a membrana; 2) incisão cutânea HORIZONTAL de 2-3 cm; 3) dissecar até expor a membrana

4) incisar diretamente a membrana cricotireoidea; 5) inserir a cânula/TOT na traqueia; 6) fixar

7) confirmar ventilação com ambu (expansão torácica bilateral + ausculta)

Alternativas: técnica de Seldinger (agulha + fio-guia + dilatador) com kit; cânula sobre agulha (mais simples, menos segura como via definitiva)

CONFIRMAÇÃO E PÓS-PROCEDIMENTO

APÓS A VIA AÉREA

- Confirmar: ventilação eficaz (movimento torácico bilateral), melhora da SpO₂, ausculta, CAPNOGRAFIA se disponível
- Monitorização contínua de oxigenação, ventilação e sinais vitais; aspirar secreções se necessário
- Fixar firmemente a cânula para evitar deslocamento
- CONVERSÃO para traqueostomia definitiva em 24-72h, após estabilização, quando possível
- Registrar horário, técnica, dificuldades e complicações

COMPLICAÇÕES

VIGIAR

- Imediatas: hemorragia, perfuração da parede posterior da traqueia, FALSO TRAJETO, mau posicionamento
- Tardias: estenose subglótica (sobretudo em crianças), infecção, traqueomalacia
- O risco de estenose subglótica é o motivo da cautela na faixa pediátrica
- Mau posicionamento/falso trajeto -> reavaliar com capnografia e ausculta
- A conversão precoce para traqueostomia reduz complicações tardias

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente ____ anos; cenário CICO por ____ (trauma facial/edema/hemorragia/obstrução); cricotireoidostomia às ____.
- Técnica: aberta/Seldinger; cânula/TOT nº ____; confirmação por capnografia/ausculta ____; SpO₂ atual ____.
- Sangramento/complicação ____; sedoanalgesia/ventilação ____.
- Solicito UTI + cirurgia/ORL para conversão em traqueostomia definitiva (24-72h); transporte com via aérea fixada e capnografia.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é a indicação clássica para a cricotireoidostomia de emergência?

- A) Qualquer dificuldade leve de intubação
- B) Cenário CICO: impossibilidade de intubar E de oxigenar com máscara/supraglóticos
- C) Apneia do sono
- D) Pneumonia
- E) Crise asmática leve

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o marco anatômico para a cricotireoidostomia?

- A) Entre o osso hioide e a tireoide
- B) Membrana cricotireoidea (entre a cartilagem tireoide e a cricoide)
- C) Sobre a glândula tireoide
- D) No 2º anel traqueal
- E) Na fúrcula esternal

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Em qual faixa etária a cricotireoidostomia é relativamente contraindicada pelo risco de estenose subglótica?

- A) Idosos
- B) Crianças pequenas (< 5-12 anos)
- C) Adultos jovens
- D) Gestantes
- E) Adolescentes

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Após a cricotireoidostomia de emergência, qual a conduta recomendada quando o paciente estabiliza?

- A) Manter a cricostomia indefinidamente
- B) Converter para traqueostomia definitiva em 24-72h
- C) Retirar a cânula imediatamente
- D) Extubar em 1h
- E) Nenhuma medida adicional

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual método confirma o correto posicionamento da via aérea após o procedimento?

- A) Apenas inspeção da pele
- B) Capnografia, com expansão torácica bilateral e ausculta
- C) Glicemia
- D) Pressão arterial isolada
- E) Frequência cardíaca isolada

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A indicação clássica é o cenário CICO ('Can't Intubate, Can't Oxygenate'): falha de intubação e de oxigenação por máscara/supraglóticos, com risco iminente de hipoxemia.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

O marco é a membrana cricótireoidea, localizada entre a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Em crianças pequenas (< 5-12 anos) há contraindicação relativa pelo risco de estenose subglótica; preferem-se alternativas (broncoscopia rígida/traqueostomia por especialista) quando possível.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Recomenda-se converter a cricotireoidostomia em traqueostomia definitiva em 24-72h, após a estabilização, para reduzir complicações tardias.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A capnografia (com expansão torácica bilateral e ausculta) confirma o posicionamento e a ventilação eficaz após o procedimento.

SM24
Suporte ao Plantão Médico